

CẨM NANG XỬ TRÍ KHI NGHI NGỜ ĐỘT QUỴ

Nhận biết sớm • Gọi cấp cứu ngay • Không tự điều trị



Đột quy là một cấp cứu y tế

Thông điệp quan trọng: Chỉ cần xuất hiện một dấu hiệu nghi ngờ, hãy gọi 115 ngay. Không chờ triệu chứng tự hết và không trì hoãn để tự theo dõi tại nhà.

Đột quy xảy ra khi dòng máu lên não bị tắc nghẽn hoặc khi mạch máu não bị vỡ. Não thiếu oxy có thể bị tổn thương chỉ trong vài phút. Việc xác định loại đột quy cần được thực hiện tại bệnh viện bằng thăm khám và chẩn đoán hình ảnh.

Vì sao phải hành động nhanh?

NHẬN BIẾT

Nhìn nhanh các dấu hiệu BE FAST.

GỌI 115

Yêu cầu xe cấp cứu; làm theo hướng dẫn của điều phối viên.

GHI THỜI GIAN

Ghi thời điểm người bệnh còn bình thường gần nhất và lúc phát hiện triệu chứng.

Không tự chẩn đoán: Hạ đường huyết, co giật, đau nửa đầu hoặc một số bệnh khác có thể giống đột quy. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu nghi ngờ, cách an toàn là xử trí như một cấp cứu và gọi 115.

Nhận biết nhanh bằng BE FAST

Các triệu chứng thường xuất hiện đột ngột. Hãy kiểm tra nhanh, không cố làm người bệnh đi lại nhiều.

B**MẮT THẲNG BẰNG**
Chóng mặt, đi không vững

E**THỊ LỰC**
Mờ mắt hoặc nhìn đôi

F**MÉO MẶT**
Cười không cân xứng

A**YẾU TAY**
Một tay rơi xuống

S**NÓI KHÓ**
Nói ngọng, khó hiểu

T**THỜI GIAN**
Gọi 115 ngay

F - Face	Yêu cầu cười: một bên mặt có xệ hoặc lệch không?
A - Arm	Yêu cầu giơ hai tay: một tay có yếu hoặc rơi xuống không?
S - Speech	Yêu cầu nhắc một câu đơn giản: lời nói có ngọng, khó hiểu hoặc không nói được không?

Triệu chứng biến mất vẫn phải cấp cứu. Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) có thể báo trước một đột quỵ thực sự; không nên tự lái xe hoặc chờ đến ngày hôm sau.

6 việc nên làm ngay

1	Gọi 115 Nói rõ địa điểm, dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, thời điểm bắt đầu và tình trạng ý thức-hô hấp.
2	Ghi thời gian Ghi giờ khởi phát hoặc thời điểm người bệnh còn bình thường gần nhất.
3	Giữ an toàn Cho người bệnh nghỉ ở tư thế thoải mái; không bắt đi lại. Nới quần áo chặt.
4	Theo dõi Quan sát ý thức, nhịp thở và dấu hiệu thay đổi; không để người bệnh ở một mình.
5	Nếu bất tỉnh Nếu vẫn thở và không nghi chấn thương, đặt nằm nghiêng an toàn. Nếu không thở bình thường, làm CPR nếu đã được đào tạo và theo hướng dẫn 115.
6	Chuẩn bị bàn giao Mang giấy tờ, danh sách thuốc, bệnh nền, dị ứng và thông tin lần dùng thuốc gần nhất.

Khi gọi 115, hãy bật loa ngoài nếu có thể để vừa chăm sóc người bệnh vừa làm theo hướng dẫn.

10 việc không nên làm

Những hành động dưới đây có thể làm chậm điều trị, tăng nguy cơ sặc hoặc gây hại.

×	Không chờ xem triệu chứng có tự hết.
×	Không tự lái xe nếu chính mình có triệu chứng.
×	Không cho người bệnh tự đi lại hoặc vận động mạnh.
×	Không cho ăn, uống hoặc ngậm thuốc khi chưa đánh giá khả năng nuốt.
×	Không tự cho aspirin: một số đột quỵ do xuất huyết và aspirin có thể làm chảy máu nặng hơn.
×	Không tự dùng thuốc hạ huyết áp hoặc tăng liều thuốc đang dùng.
×	Không cạo gió, chích máu đầu ngón tay, bấm huyệt hoặc đắp lá.
×	Không rung lắc, tát, đổ nước hoặc cố làm người bệnh “tỉnh lại”.
×	Không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc chống đông/kháng kết tập tiểu cầu.
×	Không trì hoãn vì tìm “bệnh viện tốt nhất”; hãy theo hướng dẫn của 115 để đến nơi phù hợp sớm nhất.

Đặc biệt về aspirin: Không thể phân biệt chắc chắn đột quỵ thiếu máu và đột quỵ xuất huyết chỉ bằng triệu chứng. Quyết định dùng thuốc phải do nhân viên y tế thực hiện sau đánh giá.

Ví dụ minh họa: Gia đình ông Nam

Tình huống giả định: Ông Nam, 62 tuổi, đang ăn sáng thì đột ngột làm rơi đĩa, méo miệng và nói khó.

08:15	Ông Nam đột ngột méo miệng, nói khó
08:17	Người nhà gọi 115 và ghi giờ khởi phát
08:20	Không cho ăn, uống hoặc tự dùng thuốc
08:45	Bàn giao cho bệnh viện cùng thông tin cần thiết

Thông tin nên nói với 115

Địa điểm	Số nhà, đường, phường/xã; điểm dễ nhận biết.
Dấu hiệu	Méo miệng, yếu tay chân, nói khó, mất thăng bằng, rối loạn thị lực...
Thời điểm	Giờ bắt đầu hoặc lúc cuối cùng còn bình thường.
Tình trạng	Tỉnh hay bất tỉnh; có thở bình thường không; có co giật/nôn không.
Bệnh nền & thuốc	Tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ; thuốc chống đông/kháng kết tập nếu đang dùng.

Kết quả tốt trong tình huống này không phải do “mẹo” tại nhà, mà do nhận biết sớm, gọi cấp cứu nhanh và bàn giao đủ thông tin.

Checklist có thể in và dán ở nhà

Đánh dấu từng bước khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

☐	Nhận biết ít nhất một dấu hiệu BE FAST
☐	Gọi 115 ngay
☐	Ghi giờ khởi phát hoặc lúc cuối còn bình thường
☐	Không cho ăn, uống hoặc tự dùng thuốc
☐	Theo dõi ý thức và hô hấp
☐	Chuẩn bị danh sách thuốc, bệnh nền và giấy tờ
☐	Làm theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu

THẤY DẤU HIỆU ĐỘT QUỴ → GỌI 115 NGAY
KHÔNG TỰ ĐIỀU TRỊ • MỖI PHÚT ĐỀU QUAN TRỌNG

Nguồn tham khảo và lưu ý sử dụng

Tài liệu được biên soạn cho mục đích giáo dục sức khỏe cộng đồng, dựa trên các nguồn chính thống sau:

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
Stroke fact sheet, cập nhật 19/12/2025
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/stroke>

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Signs and Symptoms of Stroke, cập nhật 19/05/2026
<https://www.cdc.gov/stroke/signs-symptoms/index.html>

American Stroke Association
Stroke Symptoms and Warning Signs; B.E. F.A.S.T.
<https://www.stroke.org/en/about-stroke/stroke-symptoms>

American Stroke Association
B.E. F.A.S.T.: Time to Call 911
<https://www.stroke.org/en/be-fast-experience/time-to-call-911>

Bộ Y tế Việt Nam
Khuyến cáo gọi cấp cứu 115/đưa người bệnh đến cơ sở điều trị đột quỵ sớm
<https://moh.gov.vn/>

NHS
Stroke requires urgent hospital treatment
<https://www.nhs.uk/conditions/stroke/>

Lưu ý: Hướng dẫn sơ cứu có thể thay đổi theo tình trạng cụ thể và chỉ dẫn của hệ thống cấp cứu địa phương. Khi gọi 115, luôn ưu tiên làm theo hướng dẫn trực tiếp của nhân viên điều phối.

TIM KHỎE MỖI NGÀY™
Kiến thức đúng - Hành động sớm - Bảo vệ người thân